

	Notfallstandard Verdacht auf Herzinfarkt	Qualitätshandbuch
		Geltungsbereich: Pflegefachkraft

Definition:

- Ein Herzinfarkt (Myokardinfarkt) wird i.d.R. ausgelöst durch den Verschluss einer Koronararterie durch einen Thrombus (Blutpfropf). Diese Gefäßverlegung hat zur Folge, dass Teile des Herzmuskels nicht mehr ausreichend mit Sauerstoff versorgt werden. Bereits nach 20 bis 30 Minuten Unterbrechung des Blutstroms beginnen die Herzmuskeln abzusterben. Nach 3 bis 6 Stunden ist die Nekrotisierung so weit fortgeschritten, dass bleibende Schädigungen zurückbleiben.
- Die Nekrose kann alle Herzwandschichten erfassen oder auf Teilbereiche begrenzt bleiben.
Je nach Lokalisation des Geschehens wird zwischen Vorderwand-, Seitenwand- und Hinterwandinfarkt unterschieden. Am häufigsten ist ein Infarkt in der linken Kammerwand.
- Die Anfälle treten häufig bei körperlicher oder bei psychischer Belastung auf. Die Beschwerden eines Angina-pectoris-Anfalls können sehr leicht mit denen eines Herzinfarktes verwechselt werden.

1. Ziel:

- Ein Herzinfarkt wird schnell und korrekt erkannt
- Bis zum Eintreffen des Notarztes wird dem Bewohner die größte mögliche Hilfe geleistet, die er in der Situation erhalten kann
- Überleben des Bewohners
- Schäden der Herzmuskulatur werden durch schnelle Therapie minimiert

2. Anwendungsbereich:

Risikofaktoren:

- Übergewicht
- Bewegungsmangel
- Bluthochdruck
- Diabetes mellitus
- Zu hohe Blutfettwerte
- Nikotinkonsum
- Emotionaler Stress
- Genetische Disposition für Sklerose

Symptome:

- Der Bewohner klagt über Schmerzen, insbesondere
 - Plötzliche, heftige Schmerzen im Brustraum
 - Ausstrahlende Schmerzen in die Arme, den Bauch, zwischen die Schulterblätter oder in den Unterkiefer
 - Schmerzen, die länger als 15 Minuten anhalten
 - Schmerzen, die deutlich stärker sind als bei vorangegangenen Angina-pectoris-Anfällen
 - Schmerzen, die sich trotz Verabreichung der Bedarfsmedikamente nicht bessern
 - Schmerzen, die sich auch bei körperlicher Entlastung nicht bessern

Freigabe	Bearbeiter	Datum	Änderung	Version	Seite	Verteiler
GF	PDL/QMB	01.01.2024		1	1	Verw./MA

Zur besseren Lesbarkeit wird die männliche Form der Anrede genutzt. Selbstverständlich sind alle Geschlechter gemeint.

 SCHINDLER INTENSIVPFLEGE	Notfallstandard Verdacht auf Herzinfarkt	Qualitätshandbuch
		Geltungsbereich: Pflegefachkraft

Es ist besonders wichtig, den Bewohner, möglichst umfassend, hinsichtlich der Schmerzen, zu befragen:

- **Wo haben Sie Schmerzen?**
- **Seit wann treten die Schmerzen auf?**
- **Sind die Schmerzen bei Belastung oder im Liegen stärker?**
- Bei jedem fünften Bewohner, vor allem bei Diabetikern, sehr alten Menschen und Frauen, kann der Infarkt auch „stumm“ auftreten, also fast beschwerdefrei. Verdächtige Symptome sind in diesem Fall **Luftnot** und **Herzrhythmusstörungen**.
- Bei Frauen treten oft atypische Beschwerden auf, wie z.B. Oberbauchschmerzen
- Weitere Symptome können auftreten:
 - Engegefühl
 - Todesangst
 - Unruhe
 - Übelkeit/ Erbrechen
 - Blasse und fahl-graue Gesichtsfarbe
 - Kalter und klebriger Schweiß im Gesicht, meist auf der Stirn oder Oberlippe
 - Verzerrter Gesichtsausdruck
 - Atemnot, die ein Hinsetzen oder Hinlegen erzwingt
 - Plötzlicher Kreislaufzusammenbruch, häufig mit Bewusstlosigkeit und kardiogenem Schock
 - Verwirrheitszustände

3. Durchführung und Zuständigkeiten:

Maßnahmen:

- Bei Gefahr von Kontamination mit Blut oder anderen Körperflüssigkeiten und Ausscheidungen sind Handschuhe zu tragen
- Die Pflegekraft löst über die Rufanlage Alarm aus und ruft weitere Kollegen herbei
- Eine Pflegekraft ruft den Notarzt/Rettungsdienst (**Rufnummer 0-112**)
- Eine Pflegekraft bleibt permanent bei dem Bewohner und beruhigt diesen, soweit möglich
- Wenn nur eine Pflegekraft vor Ort ist, muss diese, so schnell wie möglich, den Notruf absetzen
- Es wird mit der Rettungsleitstelle vereinbart, dass ein Mitarbeiter des Hauses die Rettungskräfte vom Haupteingang bis zum Zielpunkt begleitet
- Zusammenstellen der wichtigsten Informationen für den Notarzt, wie z.B.: Diagnosen, aktuelle Medikamente und die erhobenen Vitalwerte
- Nach Eintreffen des Notarztes nach ärztlicher Anordnung handeln
- Bei Herz- Kreislaufstillstand wird der Bewohner sofort reanimiert. Die Reanimation wird so lange fortgeführt, bis der Notarzt eintrifft oder das Herz des Bewohners wieder schlägt.
- Der Bewohner wird anschließend auf sein Bett gelegt und mit erhöhtem Oberkörper gelagert.
Bei einem Schock wird nur leicht erhöht gelagert
- Einengende Kleidung wird gelockert oder entfernt

Freigabe	Bearbeiter	Datum	Änderung	Version	Seite	Verteiler
GF	PDL/QMB	01.01.2024		1	2	Verw./MA

Zur besseren Lesbarkeit wird die männliche Form der Anrede genutzt. Selbstverständlich sind alle Geschlechter gemeint.

 SCHINDLER INTENSIVPFLEGE WELTWEIT KLINIKSCHNITTSTELLE	Notfallstandard Verdacht auf Herzinfarkt	Qualitätshandbuch
		Geltungsbereich: Pflegefachkraft

- Vitalwerte messen, insbesondere Blutdruck, Puls, Atmung und Bewusstseinslage
- Frischluftzufuhr gewährleisten, ggf. ein Fenster öffnen
- Verabreichen von Bedarfsmedikamenten (z.B. Nitrospray) nur nach ärztlicher Anordnung
- Die Krankenhauseinweisung wird gemäß der Verfahrensanweisung vorbereitet

Nachbereitung:

- Information an die Pflegedienstleitung oder stellvertretende PDL.
Wenn die Notsituation am Wochenende/ Feiertag eintritt, dann wird die Information am nächsten Werktag weitergegeben
- Information an Angehörige/ Betreuer
- Information an den Hausarzt
- Bei Krankenhauseinweisung ist immer auch die Verwaltung zu informieren

Dokumentation:

Der Verlauf der Geschehnisse, von den ersten Symptomen bis zum Eintreffen des Notarztes wird noch einmal im Team besprochen. Ziel ist es ggf. aufgetretene Probleme zu reflektieren und das Handeln in Notsituationen zu verbessern

Dokumentiert wird unter:

- Berichtesblatt
- Ärztliche Kommunikation
- Vitalwerte
- Pflegeüberleitungsbogen
- Alle getroffenen Maßnahmen werden genau dokumentiert

Durchführungsverantwortlichkeit/ Qualifikation:

- Alle Pflegekräfte

Prozessverantwortlichkeit:

- Pflegedienstleitung, QMB, stellvertretende PDL, Wohnbereichsleitung

Freigabe	Bearbeiter	Datum	Änderung	Version	Seite	Verteiler
GF	PDL/QMB	01.01.2024		1	3	Verw./MA

Zur besseren Lesbarkeit wird die männliche Form der Anrede genutzt. Selbstverständlich sind alle Geschlechter gemeint.